

L'embolie pulmonaire

L'embolie pulmonaire est une cause fréquente d'hospitalisation en urgence et de décès. Provoquée par la migration et l'immobilisation d'un caillot de sang dans l'une des artères pulmonaires, elle est le plus souvent la complication d'une thrombose veineuse au niveau des jambes (phlébite) ou du bassin. Le traitement et la prévention de l'embolie pulmonaire reposent sur l'administration de médicaments anticoagulants, mais également sur la mise en place de mesures de prévention des phlébites : bas de contention, arrêt du tabac et de la contraception hormonale, par exemple.

L'embolie pulmonaire est l'obstruction **plus ou moins complète d'une artère pulmonaire, ou d'une branche de cette artère, le plus souvent par un caillot sanguin**. C'est une urgence médicale qui peut parfois être mortelle. Généralement, le caillot s'est formé dans une **veine profonde de la jambe** et a migré dans la circulation sanguine pour atteindre d'abord le cœur, puis l'artère pulmonaire. Dans la vaste majorité des cas, une embolie pulmonaire diagnostiquée et traitée à temps ne met pas en danger la vie du patient. **La gravité d'une embolie pulmonaire** est fonction du degré d'obstruction de l'artère pulmonaire, de l'état de santé du patient (état cardiaque et respiratoire), et du délai avec lequel le diagnostic est posé. Lorsque plus de la moitié du diamètre de l'artère pulmonaire est bouchée, on parle d'**embolie pulmonaire « massive »** qui peut entraîner une insuffisance cardiaque, voire un arrêt cardiaque.

Chaque année, en France, on estime qu'entre **65 et 130 000 personnes font une embolie pulmonaire**. Mais dans 40 à 50 % des cas, les symptômes sont absents. Néanmoins, l'embolie pulmonaire est, en termes de fréquence, la **troisième maladie cardiovasculaire** (après l'infarctus du myocarde-crise cardiaque et l'accident vasculaire cérébral) avec environ 35 000 hospitalisations chaque année. L'embolie pulmonaire serait à l'origine d'environ **15 000 décès par an en France**, essentiellement dans les cas sévères d'apparition brutale, ceux où le diagnostic n'a pas été posé, ou chez des patients âgés ou souffrant d'autres maladies graves. **Dans la vaste majorité des cas, une embolie pulmonaire diagnostiquée et traitée ne met pas en danger la vie du patient.**

En dépit de sa gravité potentielle, l'embolie pulmonaire est une maladie le plus souvent discrète, avec des symptômes peu intenses et peu caractéristiques. Le plus fréquemment, la personne se plaint d'une douleur semblable à celle du point de côté, plus intense à l'inspiration. Parfois cette douleur se situe derrière le sternum. Elle s'accompagne progressivement d'une respiration courte, plus rapide et superficielle, avec parfois une accélération du rythme cardiaque. Plus rarement, le patient tousse et peut rejeter des crachats teintés de sang. Plus rarement, d'autres symptômes peuvent être observés : un **malaise**, une **fièvre légère**, de l'**anxiété**, etc. Si l'embolie pulmonaire est due à une phlébite de la jambe, celle-ci peut être légèrement enflée et douloureuse sur le trajet de la veine touchée. Dans les cas plus sévères, la personne peut présenter une coloration bleue des lèvres et de l'extrémité des doigts, perdre connaissance en se levant, ou faire un choc, voire un arrêt cardiaque.

Lorsque des symptômes évocateurs d'embolie pulmonaire sont observés, en particulier chez une personne qui a des antécédents de phlébite, **mieux vaut appeler les services d'urgence**. En attendant leur arrivée, il est préférable d'**installer la personne en position semi-assise** et l'empêcher de se lever ou de se déplacer.

Le médecin prescrit des anticoagulants et, éventuellement, des médicaments destinés à dissoudre le caillot. Le patient peut également recevoir une supplémentation en oxygène et des médicaments pour renforcer le fonctionnement du cœur. Une hospitalisation de courte durée est parfois nécessaire. Le patient reste allongé les jambes surélevées le premier jour, mais rapidement il doit se lever, se déplacer et porter des bas de contention.

Embolie pulmonaire, Vidal Recos, 11/2016

Répondez aux questions suivantes :

I- Compréhension :

- 1- Qu'est-ce que l'embolie pulmonaire ?
- 2- Quelle est la cause la plus fréquente de l'embolie pulmonaire ?

- 3- Comment peut-on prévenir l'embolie pulmonaire ?
- 4- Comment se forme généralement le caillot responsable de l'embolie pulmonaire ?
- 5- Quels sont les symptômes de l'embolie pulmonaire ?
- 6- Dans quels cas l'embolie pulmonaire peut-elle être mortelle ?
- 7- Quel est le traitement de l'embolie pulmonaire ?
- 8- Comment doit se comporter une personne présentant des symptômes évocateurs d'embolie pulmonaire avant l'arrivée des services d'urgence ?
- 9- Quelle est la durée d'hospitalisation nécessaire en cas d'embolie pulmonaire ?
- 10- Quels sont les conseils donnés pour la récupération après une embolie pulmonaire ?

II- Fonctionnement de la langue :

- 1- Quel sont les sujets traités dans le premier et le dernier paragraphe ?
- 2- Quel est le sens du mot "discrète" dans le contexte de la maladie ?
- 3- Dans quel temps est conjugué le verbe de cette phrase est conjugué « *On estime qu'entre 65 et 130 000 personnes font une embolie pulmonaire chaque année* » Re conjuguez ce verbe à l'imparfait de l'indicatif.
- 4- Trouvez dans le texte deux adverbes, déterminez leur signification.
- 5- Trouvez dans le texte une démonstration et une possession.

III- Production : En quelques lignes, résumez le texte précédent tout en modifiant sa forme et en gardant que l'essentiel à comprendre.

- Conjuguez les verbes sous leur forme correcte.
- Employez votre propre vocabulaire et utilisez les signes de ponctuation convenables.
- Afin d'éviter la répétition, utilisez convenablement les pronoms personnels.